

LES ADENOPATHIES CERVICALES

13/04/2026

**Pr HEMMAOUI B
SERVICE ORL HMIMV RABAT**

I-INTRODUCTION :

- * Hypertrophie pathologique d'une formation ganglionnaire pouvant résulter :
 - D'une réaction lymphocytaire et/ou macrophagique locorégionale ou générale, de nature infectieuse ou tumorale,
 - De la prolifération tumorale primitive du tissu lymphoïde (lymphome),
 - D'un envahissement par des cellules malignes (métastases ganglionnaires)

I-INTRODUCTION :

- * Pathologie fréquente et d'étiologie très variée
- * ADP unique ou polyADP ,aigue ou chronique
- * Diagnostic positif facile
- * Peuvent être infectieuses mais il faut craindre des pathologies cancéreuses
- * L'éventualité d'une adénopathie métastatique ou d'une hémopathie maligne : Hantise des ORL

I-INTRODUCTION :

- * Biopsie proscrite+++

- * L'intérêt : * Examen clinique rigoureux

- *Examens para cliniques

- appropriés

- *Stratégie thérapeutique définie

Cercle ganglionnaire pericervical

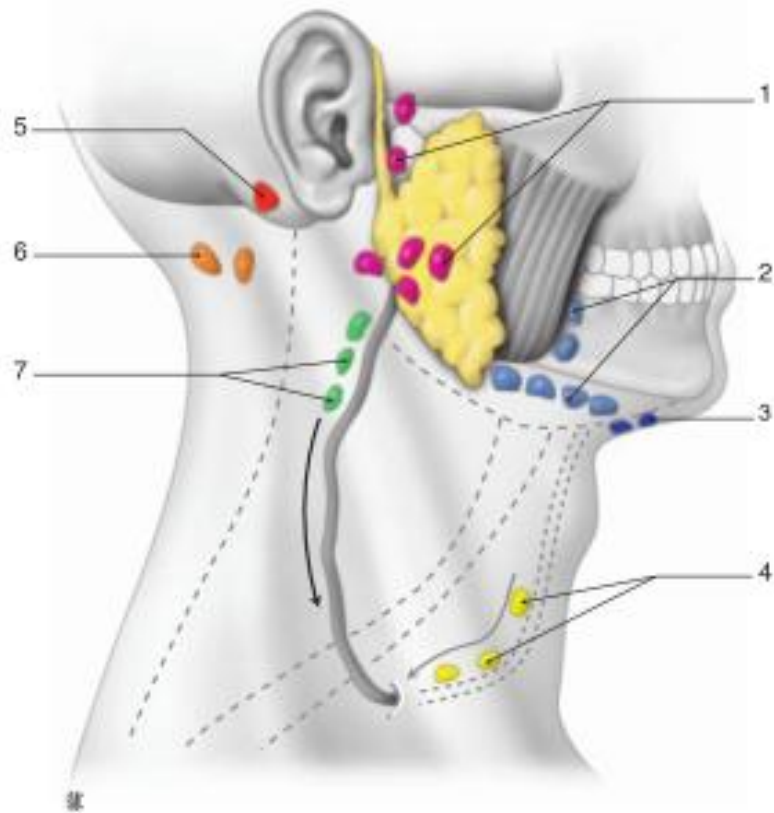


Figure 1. Ganglions cervicaux superficiels. 1. Ganglions parotidiens ; 2. ganglions submandibulaires ; 3. ganglions submentaux ; 4. ganglions satellites de la veine jugulaire antérieure ; 5. ganglions rétroauriculaires (mastoidiens) ; 6. ganglions occipitaux ; 7. ganglions satellites de la veine jugulaire externe.

Cercle ganglionnaire cervical

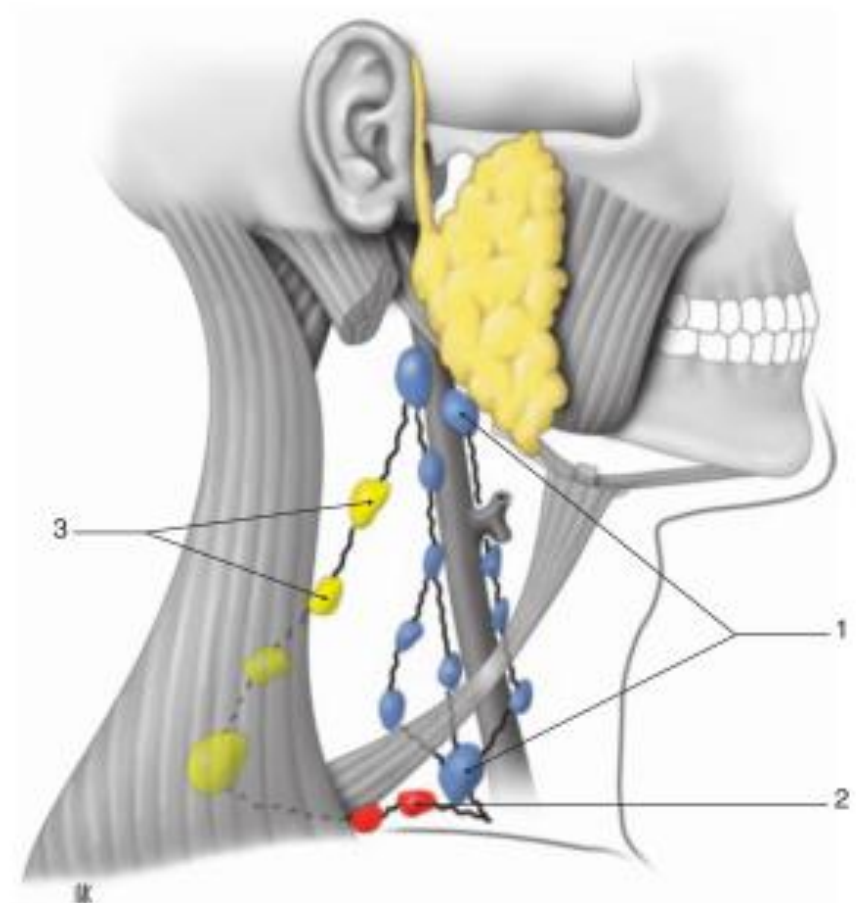
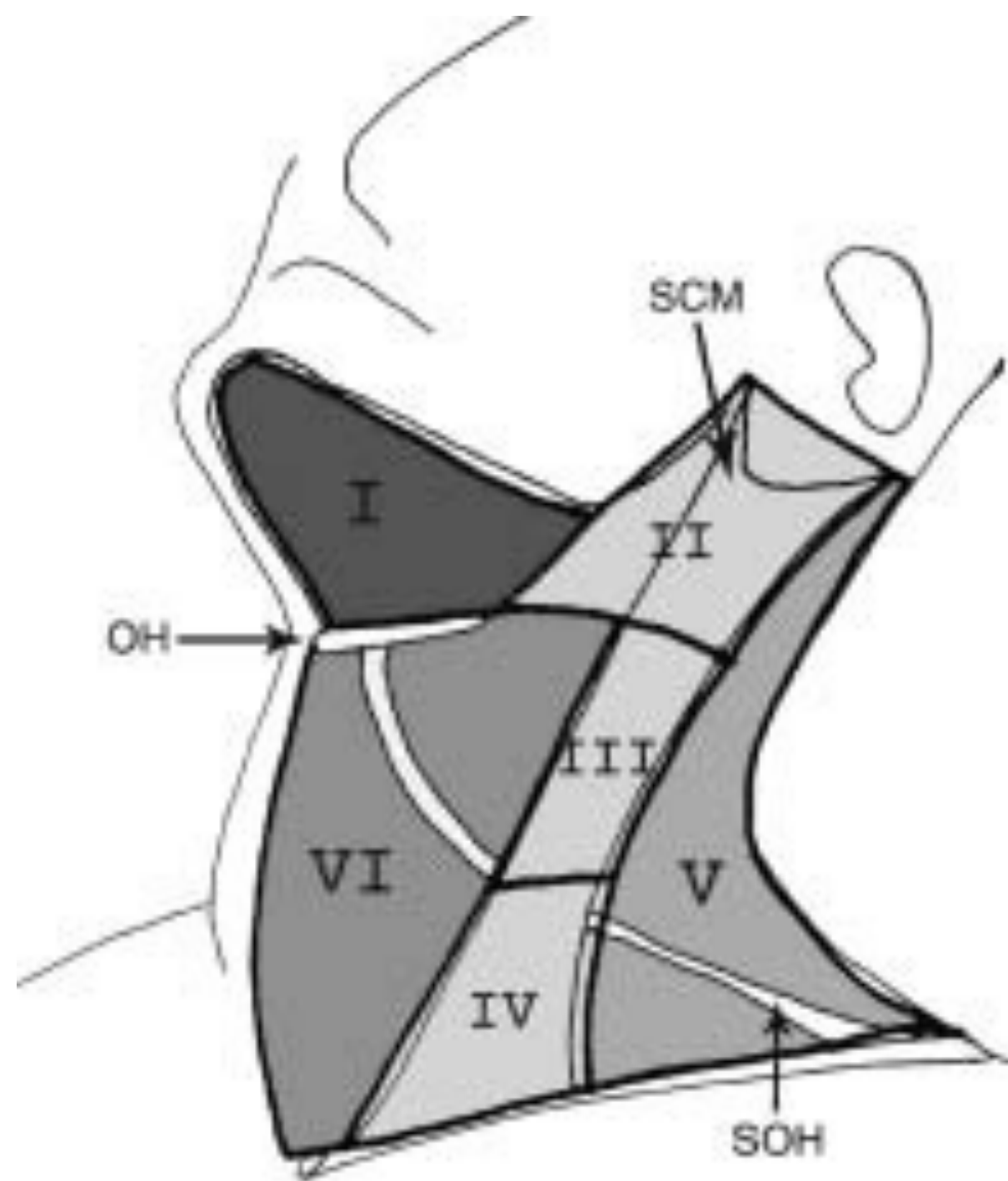


Figure 3. Triangle lymphatique du cou. 1. Chaîne jugulaire interne ; 2. chaîne cervicale transverse ; 3. chaîne spinale.

Triangle de Rouvière





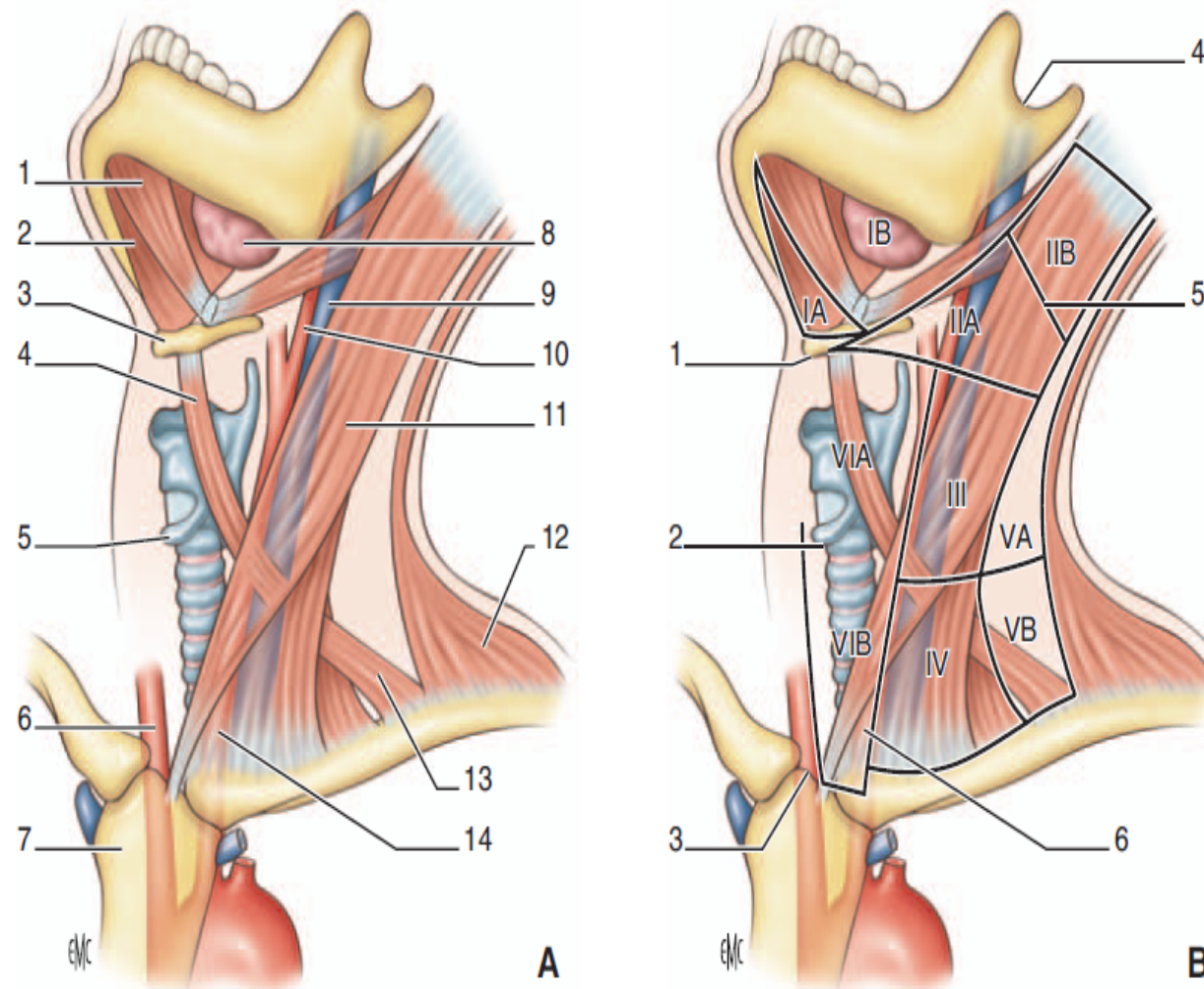


Figure 1. Classification radiologique des niveaux ganglionnaires cervicaux.

A. Anatomie. 1. Muscle digastrique ; 2. muscle mylo-hyoïdien ; 3. os hyoïde ; 4. muscle omo-hyoïdien ; 5. cartilage cricoïde ; 6. artère carotide primitive droite ; 7. manubrium ; 8. glande submandibulaire ; 9. veine jugulaire interne ; 10. artère carotide interne ; 11. muscle sterno-cléido-mastoidien ; 12. muscle trapèze ; 13. scalène antérieur ; 14. artère carotide primitive gauche.

B. Niveaux ganglionnaires et leurs limites anatomiques. 1. Bord inférieur de l'os hyoïde ; 2. bord inférieur du cartilage cricoïde ; 3. bord supérieur du manubrium ; 4. foramen jugulaire ; 5. bord postérieur de la glande submandibulaire ; nerf accessoire ; 6. artère carotide primitive gauche.

Classification radiochirurgicale des niveaux ganglionnaires cervicaux.

Désignation des niveaux ganglionnaires Limites chirurgicales

I Groupe submento-submandibulaire **IA Submental** Ventres antérieurs des muscles digastriques et l'os hyoïde

IB Submandibulaire Muscle digastrique et branche horizontale de la mandibule

II Jugulocarotidien supérieur **IIA Sous-digastrique** Ventre postérieur du muscle digastrique en haut, nerf XI en arrière, ligne horizontale passant par l'os hyoïde en bas

IIB Rétrospinal **Base du crâne en haut**, bord postérieur du SCM en arrière, le nerf XI en avant

III Jugulocarotidien moyen Bord postérieur du SCM en arrière, bord médial de l'axe carotidien en avant, et deux lignes horizontales passant par l'os hyoïde en haut et le bord inférieur du cricoïde en bas

IV Jugulocarotidien inférieur Bord postérieur du SCM en arrière, le bord médial de l'axe carotidien en avant, depuis le niveau du bord inférieur du cartilage cricoïde jusqu'à la Clavicule

V Triangle postérieur VA Triangle postérosupérieur

Bord postérieur du SCM en avant, bord antérieur du muscle trapèze en arrière et au-dessus du plan passant par le bord inférieur du cricoïde

VB Triangle postéro-inférieur Bord postérieur du SCM en avant, bord antérieur du muscle trapèze en arrière, la clavicule en bas et au-dessous du plan passant par le bord inférieur du cricoïde

VI Cervical antérieur VIA Prélaryngé Os hyoïde en haut, bord inférieur du cricoïde en bas et bord médial des axes carotidiens latéralement

VIB Péritrachéal Bord inférieur du cricoïde en haut, bord médial des axes carotidiens latéralement et manubrium sternal en bas

III-DIAGNOSTIC POSITIF :

- * But : - confirmation du diagnostic
- préciser l'origine et la nature

Interrogatoire : préciser

- L'âge
- Les antécédents et les facteurs de risque
- Mode de début et évolutif
- Signes fonctionnels: dyspnée, dysphagie, dysphonie, épistaxis, obstruction nasale....

2- Examen clinique :

- Nombre des ADP.
- Caractère: uni ou bilatéral
- Siège d'origine
- Taille
- Caractéristique douloureuse ou non
- Mobilité
- Aspect des téguments en regard.
- Consistance.
- L'examen des autres aires ganglionnaires cervicales

2- Examen clinique :

- Examen ORL complet :

- Examen des téguments de la face et du cuir chevelu
- Examen des glandes : thyroïde
salivaires principales
- Examen de la cavité orale et de l'oropharynx
Palper+++
- Examen des fosses nasales, larynx et du cavum
- Examen otoscopique
- Examen neurologique

2- Examen clinique :

-Examen somatique général :

Aires ganglionnaires extra cervicales

Examen abdomino-pelvien : rate, foie,
masse.

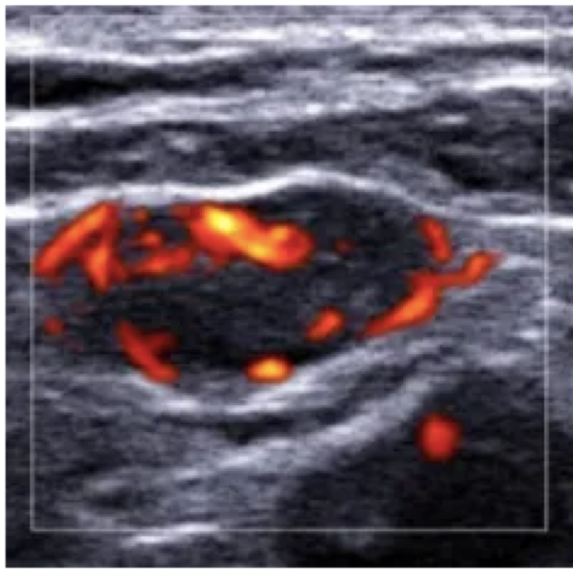
Examen pleuropulmonaire

Examen des téguments

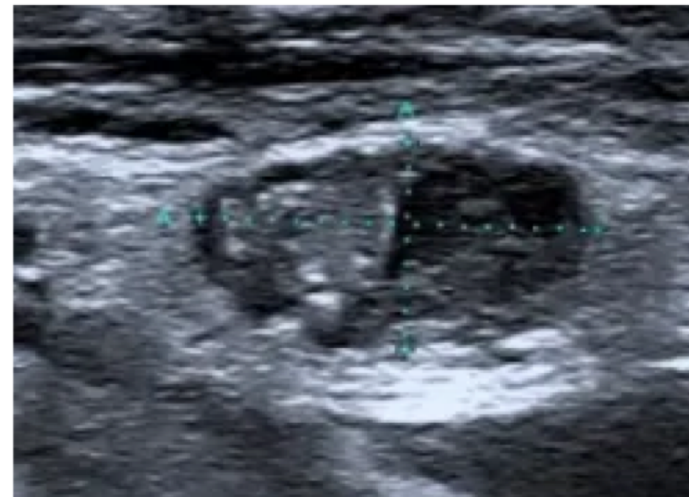
3- Examens complémentaires :

a- Imagerie : Intérêts et indications

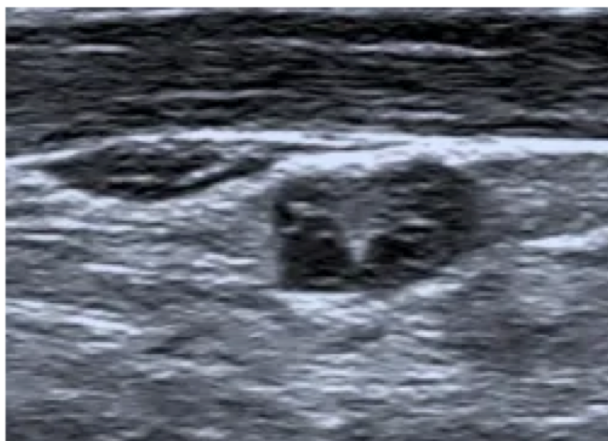
- * Radio pulmonaire
- * Echographie cervicale
- * Scanner
- * Résonance magnétique nucléaire (RMN)
- * Tomographie d'émission de positions (TEP)
ou PET SCAN



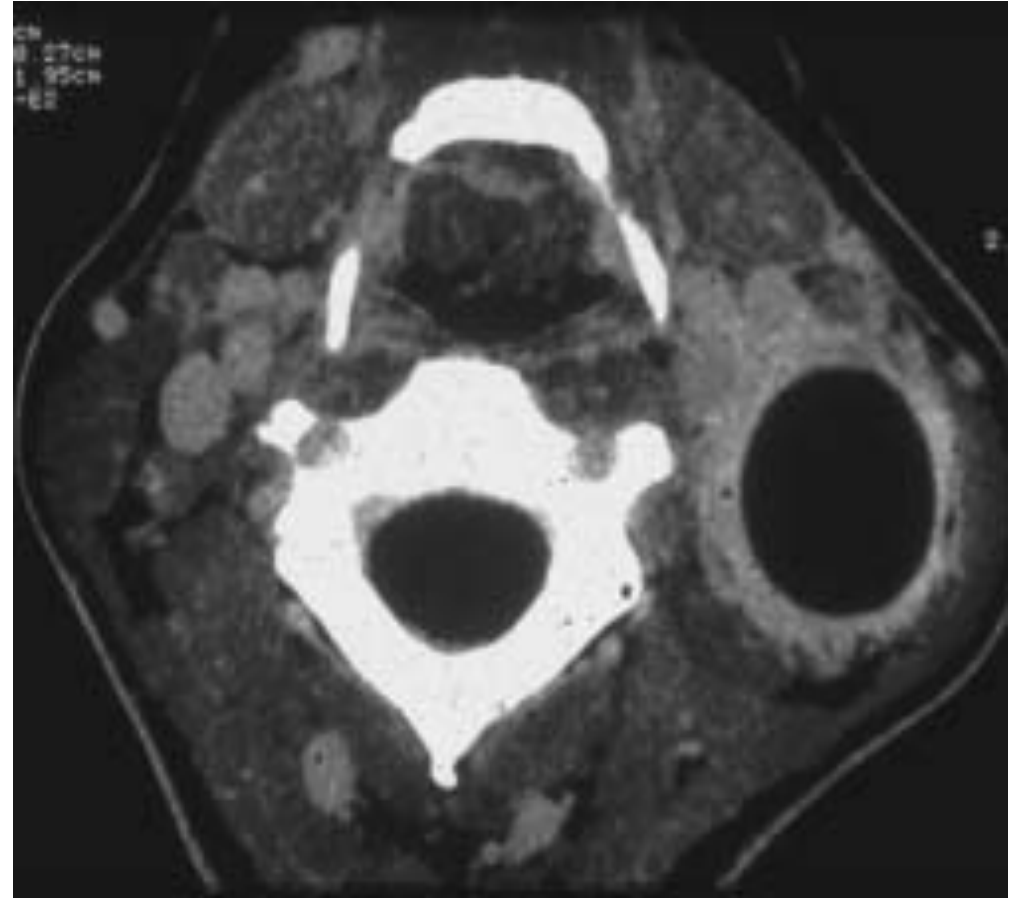
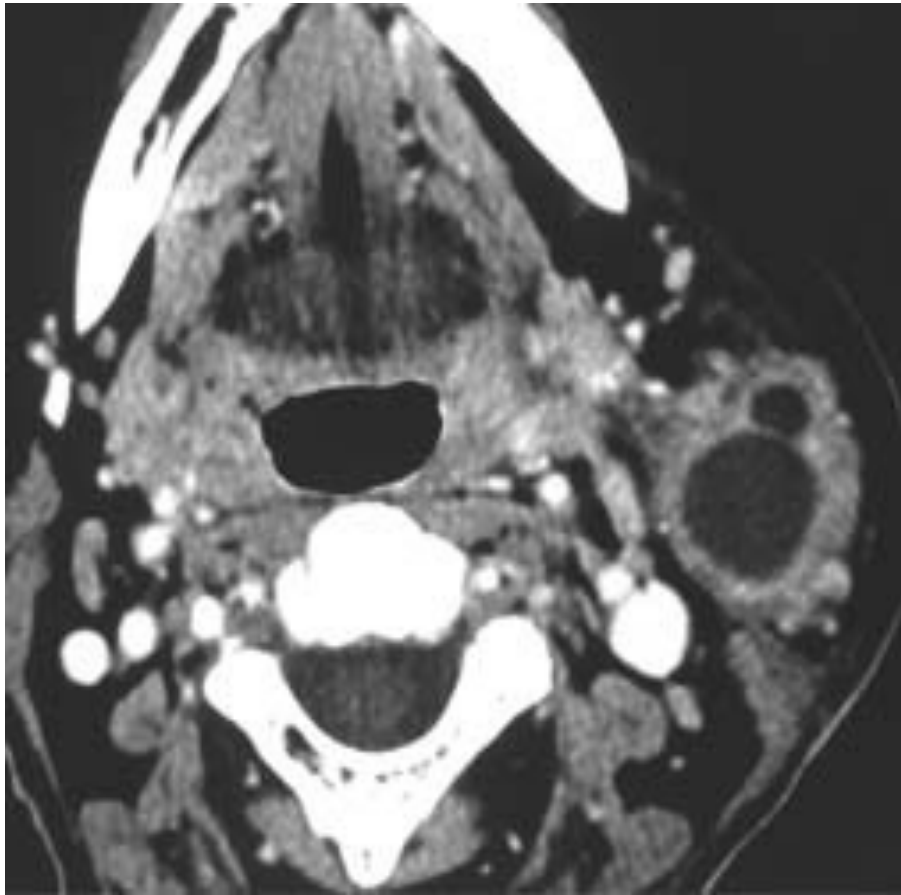
Vascularisation périphérique : danger !

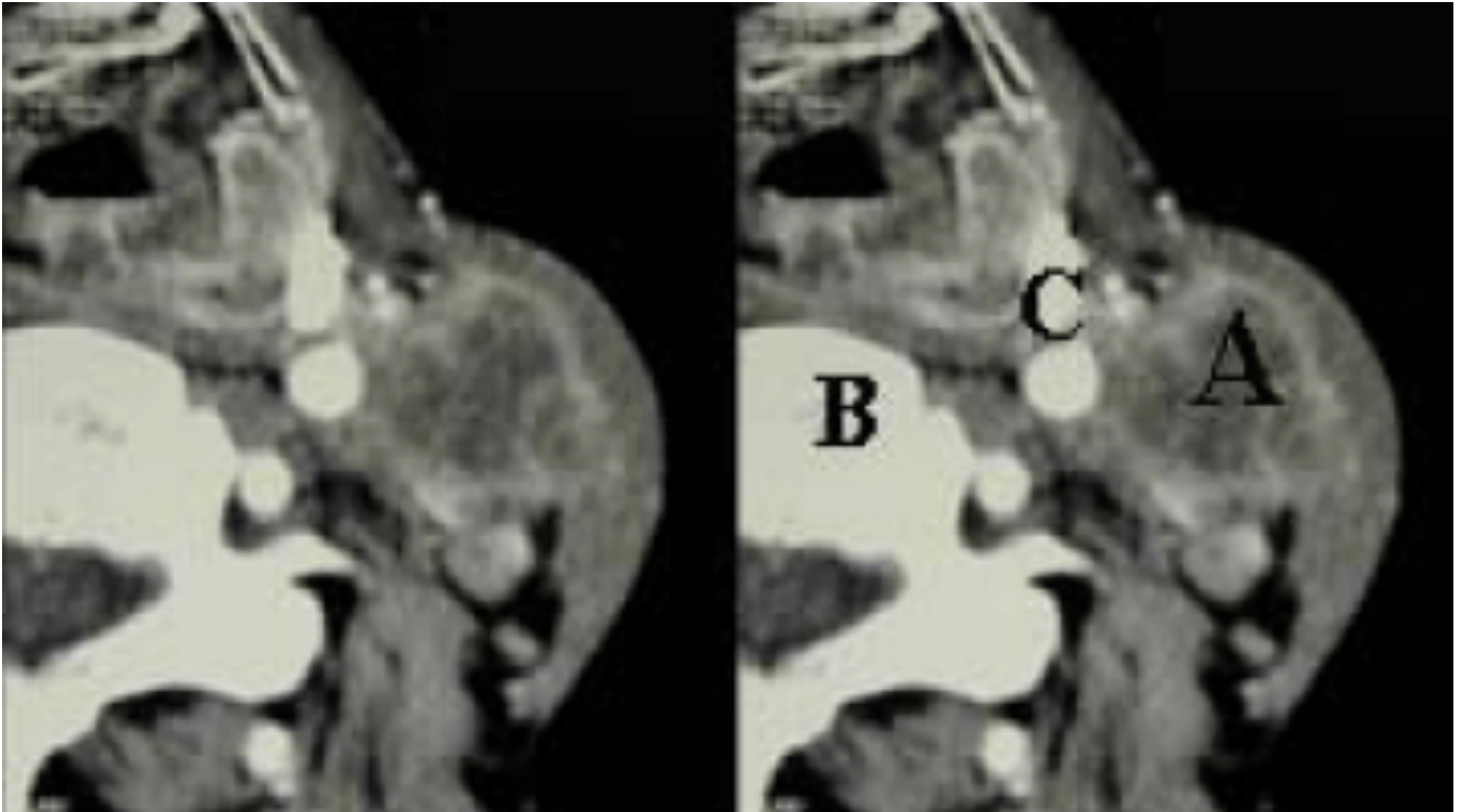


Calcification : danger !

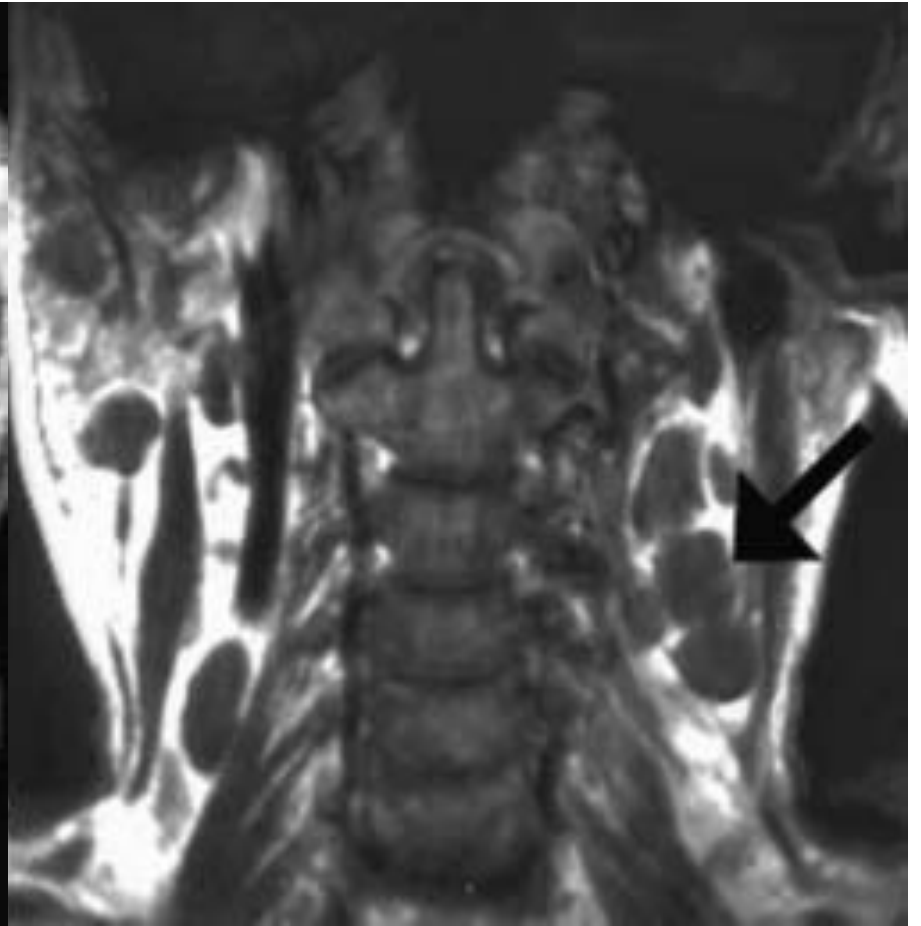
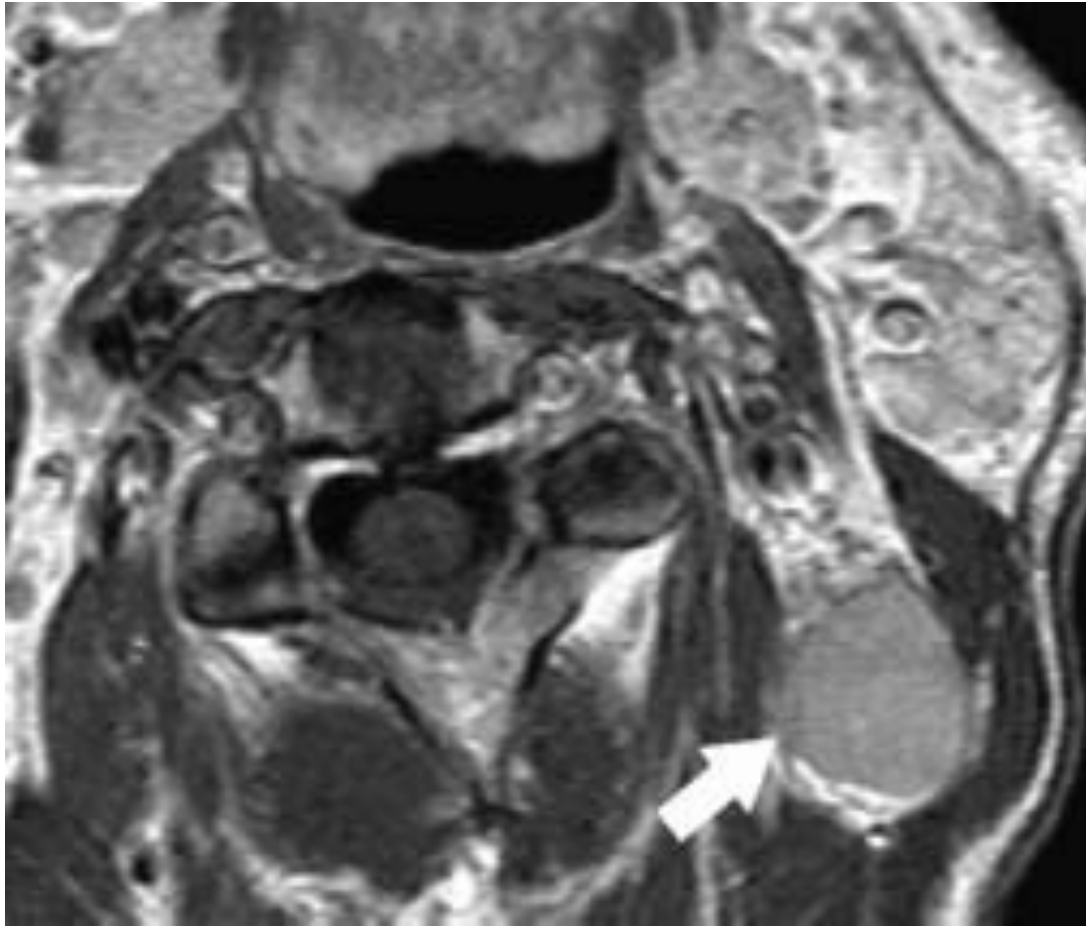


Logettes anéchogènes : danger !





- Adenopathies metastatiques d'un cancer des VADS



3- Examens complémentaires :

b- Parendoscopie : intérêt et indications

C-Examens anatomopathologiques : Intérêt et indications

- * Ponction cytologique de l'ADP
- * Cervicotomie exploratrice avec analyse histologique extemporané de l'ADP

d-Autres examens :

- * Biologique : NFS et VS
- * Tests sérologiques: MNI, VIH, syphilis.
- * IDR à la tuberculine....

IV-DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL :

1-Tuméfaction sous mentale:

- Kyste dermoïde médian
- Grenouillette sus hyoïdienne
- Cellulite d'origine dentaire

IV-DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL :

2- REGION SOUS MANDIBULAIRE:

- Pathologie de la glande sous maxillaire
- Cellulite d'origine dentaire
- Kyste dermoïde latéral
- Lymphangiome kystique

IV-DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL :

3- REGION PAROTIDIENNE:

- Tumeurs parotidiennes.
- Parotidites
- Tumeurs nerveuses

IV-DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL :

4- REGION JUGULO CAROTIDIENNE:

- Kyste congénital
- Tumeurs nerveuses ou vasculaires
- Lymphangiome kystique
- Tumeurs du glomus carotidien



IV-DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL :

5- REGION SOUS HYOIDIENNE MEDIANE:

- Kyste du tractus thyroéoglosse
- Laryngocèle



V- DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE ET TRAITEMENT

- * Les adénopathies aiguës
- * Les adénopathies chroniques

1-Les adénopathies aiguës :

-Etiologies : virale ou bactérienne

a- Etiologies virales :

1-Mononucléose infectieuse

- DGC: FNS, MNI test
- Début: angine érythématopultacée,
ulcéronécrotique, pseudo-membraneuse.
- Poly ADP sous max, spinale, splénomégalie.
- TRT: symptomatique + repos au lit.

1-Les adénopathies aiguës :

-Etiologies : virale ou bactérienne

a- Etiologies virales :

2- Primo-infection rubéolique

- PolyADP cervicales, mobiles, petites, sensibles.
- Arthralgie.
- DGC: FNS, dosage des anticorps.
- TRT: symptomatique.

1-Les adénopathies aiguës :

-Etiologies : virale ou bactérienne

a- Etiologies virales :

3- Rougeole:

- ADP cervicales, mobiles, petites

1-Les adénopathies aiguës :

-Etiologies : virale ou bactérienne

a- Etiologies virales :

4- Autres ADP:

- Cytomégalovirus.
- Virus herpès Zoster.
- Adénovirus.
- Virus coxsackie et échovirus.

b-Infections bactériennes :

*Porte d'entrée+++ : -cutanée

-muqueuse

-dentaire

*Germe fréquents :- staphylocoque doré

- streptocoque B hémolytique A

- Germe anaérobies

* Tableau clinique : -Adénites aiguës
inflammatoires

- Adénites aiguës suppurées

- Adénophlegmon

*Traitement

b-Infections bactériennes :

- **Adénite aigue:**
 - Premier stade congestif ou séreux
 - Augmentation rapide du volume
 - Douleur
 - Peau chaude érythémateuse
 - Évolution: suppuration, fluctuation, fistulisation
 - Atteinte de l'état général

- **Adénophlégmon:**

- Aggravation des signes locaux et généraux
- Siège préférentiel: région jugulo-carotidienne
- Complications locales ou régionales

2- Adénopathies chroniques :

- Aspect: ferme et indolore
- Etiologies : sont multiples
- plus de 3 semaines

a-Infectieuses :

1- Bactériennes

2- Parasitaires

a-1- Bactériennes :

➤ **Tuberculose :**

- DGC: interrogatoire, signes généraux, examens complémentaires (Rx pulmonaire, IDR).
- ADP chroniques +++
- ADP chronique calcifiée.

a-Infectieuses :

a-1- Bactériennes :

➤ Syphilis :

- ADP sous mandibulaires groupées, volumineuses, dures, indolores, mobiles.
- DGC: - examens sérologiques
 - Ponction du ganglion
 - Raclage du chancre.
- Persistance 2 à 4 mois après TRT.

a-Infectieuses :

a-1- Bactériennes :

➤ Maladie des griffes du chat :

- Age: 18 ans
- ADP volumineuse, satellite du point d'inoculation, papule rouge, indolore.
- Suppuration + fistulisation: pus jaune verdâtre.
- DGC: IDR (+) à l'antigène de Reilly + biopsie.
- TRT: drainage + cyclines.



a-Infectieuses :

a-1- Bactériennes :

➤ Actinomyose

- ADP sous angulo mandibulaire, ligneuse, adhérente.
- Fistulisation: grains jaunes.
- DGC: la bactériologie + examen direct du pus.
- TRT: pénicilline (6 à 12 mois)

a-Infectieuses :

a- 2 Parasitaires :

➤ **Toxoplasmose**

- Primo infection: ADP occipitales, spinales, multiples, indolores et mobiles.
- Persistance: 6 à 12 mois.
- DGC: sérologie.

a-Infectieuses :

a- 2 Parasitaires :

➤ Leishmaniose:

- L'atteinte ganglionnaire peut être isolée ou associée à des manifestations cutanées, muqueuses ou viscérales.

a-Infectieuses :

a- 2 Parasitaires :

➤ Trypanosomiasis:

- ADP cervicales postérieures, indurées.

➤ Echinococcose:

- ADP indolore, molle, fluctuante, mobile, à contours lisses.

a-Infectieuses :

a- 3 ADP D'ORIGINE MYCOSIQUE :

➤ Histoplasmosse:

- ADP volumineuses, localisées, non inflammatoires, froides avec atteinte cutanée.

➤ Autres:

- Sporotrichose.
- Coccidioidomycose.
- Paracoccidioidomycose.

a-Infectieuses :

a- 4 Cas particulier de l'infection par le VIH :

- Lymphadénopathie persistante généralisée
- Infections opportunistes :
 - Tuberculose
 - Mycobactéries atypiques

b- ADP D'ORIGINE INFLAMMATOIRE

IMMUNO ALLERGIQUE :

➤ Sarcôïdose:

- ADP cervicales, sus claviculaires, fermes, mobiles, indolores, petites,.
- Ne passe jamais au stade de suppuration.

b- ADP D'ORIGINE INFLAMMATOIRE

IMMUNO ALLERGIQUE :

- **Connectivites et maladies auto immunes de système:**
 - Lupus érythémateux: ADP cervicales diffuses.

b- ADP D'ORIGINE INFLAMMATOIRE

IMMUNO ALLERGIQUE :

➤ Adénite nécrosante de Kikuchi:

- ADP douloureuse, cervicale, unique, (parfois thoracique ou abdominale).
- DGC: histologique.

b- ADP D'ORIGINE INFLAMMATOIRE

IMMUNO ALLERGIQUE :

➤ Autres ADP:

- Lymphadénopathie angio-immunoblastique.
- Hyperplasie ganglionnaire giganto-cellulaire.
- Histiocytose sinusale.
- Syndrome de Chediak Higashi.

b- ADP D'ORIGINE INFLAMMATOIRE

IMMUNO ALLERGIQUE :

➤ ADP réactionnelles aux médicaments:

- Médicaments: produits iodés, phénylbutazone..
- ADP régressent après l'arrêt du médicament.

b- ADP D'ORIGINE TUMORALE:

➤ Lymphome Hodgkinien :

- Age avant 30 ans.
- Début: ADP unique ou plusieurs, basses, superficielles, unilatérales, +/- fermes, indolores.
- Évolution: bilatéralisation cervicale, dissémination générale.
- Ponction: cellules de Sternberg.
- DGC: adénectomie.

b- ADP D'ORIGINE TUMORALE:

- **Lymphome non Hodgkinien :**
 - Age: plus de 50 ans.
 - ADP est un signe précoce, élastiques, mobiles, multiples, sus claviculaires++.

b- ADP D'ORIGINE TUMORALE:

➤ Leucémies:

- Leucémies lymphoïdes chroniques: ADP volumineuses, fermes, élastiques, mobiles, bilatérales, symétriques, cervicales et sus claviculaires.
- Leucémies lymphoblastiques aiguës: ADP diffuses, indolores, fermes et mobiles.

b- ADP D'ORIGINE TUMORALE:

➤ Carcinome épidermoïde , UCNT :

- ADP dures, ligneuses, indolores, mobiles puis fixées, peuvent être primitives ou non.

b- ADP D'ORIGINE TUMORALE:

➤ Adénopathies métastatiques :

- Signes cliniques
- Etiologie et traitement :

* ADP maligne en apparence primitive



CONCLUSION :

- Adénopathie cervicale : situation clinique très fréquente
- Intérêt d'un examen clinique rigoureux et un bilan para clinique adéquat.
- Distinguer : adénopathie aigue et adénopathie chronique
- Etiologie dominées par la pathologie infectieuse et tumorale
- Ne pas passer à côté d'une étiologie maligne
- Jamais de biopsie sur une adénopathie cervicale